

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PIAUI
MUNICÍPIO: PADRE MARCOS

Relatório Anual de Gestão 2025

MARIA LUCIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação

- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação por local de residência
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS

- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira

- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	PI
Município	PADRE MARCOS
Região de Saúde	Chapada Vale do Rio Itaim
Área	319,12 Km²
População	6.468 Hab
Densidade Populacional	21 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 13/03/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número CNES	7908318
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	01920440000120
Endereço	AVENIDA JOSE DE MOURA LEAL S/N PREDIO
Email	smspadremarcospi@hotmail.com
Telefone	8934311284

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 13/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	WILIANE KELLY DA SILVA
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	MARIA LUCIA DA SILVA
E-mail secretário(a)	publikacontabilidade@hotmail.com
Telefone secretário(a)	86994272718

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 13/03/2026

Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	01/1991
CNPJ	11.969.361/0001-67
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	MARIA LUCIA DA SILVA

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 13/03/2026

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Chapada Vale do Rio Itaim

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ACAUÃ	1029.41	6323	6,14
BELÉM DO PIAUÍ	220.933	3515	15,91
BETÂNIA DO PIAUÍ	1092.305	6596	6,04
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	514.307	5602	10,89
CARIDADE DO PIAUÍ	423.369	5176	12,23
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	765.534	5191	6,78
FRANCISCO MACEDO	117.317	2985	25,44
JACOBINA DO PIAUÍ	1443.257	5711	3,96
JAICÓS	854.342	17789	20,82
MARCOLÂNDIA	137.069	8822	64,36
MASSAPÊ DO PIAUÍ	525.619	5165	9,83
PADRE MARCOS	319.124	6468	20,27
PATOS DO PIAUÍ	723.273	5427	7,50
PAULISTANA	1751.993	21633	12,35
QUEIMADA NOVA	1499.865	8948	5,97
SIMÕES	1023.917	14664	14,32

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Instrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	AV. JOSE DE MOURA LEAL	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	FRANCIMEIRY JULIETA DE CARVALHO	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	8
	Governo	4
	Trabalhadores	4
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa	Data de Apresentação na Casa Legislativa

• Considerações

As informações referentes à identificação territoriais, secretaria municipal de saúde, gestão, fundo de saúde, plano de saúde, regionalização citada no relatório anual de gestão estão de acordo com as informações do município de Padre Marcos - PI. Porém tem que alterar as informações do Conselho Municipal de Saúde e dos dados dos seus conselheiros.

Assim, a SMS de Padre Marcos - PI disponibiliza o presente relatório, que se constitui num importante documento para conhecimento dos gastos e ações desenvolvidas pela gestão e, consequentemente, para a avaliação da mesma, onde todos poderão contribuir efetivamente para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no município de Padre Marcos - PI.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O presente relatório apresenta o desempenho da gestão municipal do SUS no exercício 2025. O documento traz demonstrativos da execução das iniciativas indicadas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025, aprovado por deliberação do Plenário Conselho Municipal de Saúde (CMS). Os demonstrativos apresentados no RAG acompanham e avaliam as iniciativas operacionalizadas pela Programação Anual de Saúde (PAS) em consonância com o planejamento quadrienal indicado no Plano Municipal de Saúde (PMS), visando alcançar os objetivos do SUS.

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um instrumento de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo qual se verifica a efetividade e a eficiência alcançadas na atenção integral à saúde. É uma ferramenta que subsidia as atividades de controle e auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na gestão do SUS.

Os objetivos RAG é acompanhar o cumprimento das metas pactuadas ao mesmo que indicar os ajustes necessários do plano municipal de saúde. A fundamentação legal baseia-se na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 / 90 e Art. 18: À direção municipal do SUS compete: Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Lei nº 8.142 / 1990 - Art. 4: Municípios, Estados e Distrito Federal para receber recursos deverão elaborar o Relatório de Gestão e submetê-lo a apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Portaria MS / GM nº. 3.332 /2006. - Art. 1: Entre os instrumentos básicos do planejamento do SUS: Relatório Anual de Gestão.

O esforço de reorganização do modelo de atenção da saúde concretiza-se com a missão principal no alcance de um grau de resolubilidade e ações que possam fortalecer a atenção básica potencializando estratégias no sentido de alcançar equidade, integralidade e hierarquização na assistência à saúde na rede de atenção.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	184	176	360
5 a 9 anos	222	202	424
10 a 14 anos	223	210	433
15 a 19 anos	215	221	436
20 a 29 anos	426	437	863
30 a 39 anos	445	475	920
40 a 49 anos	443	496	939
50 a 59 anos	406	480	886
60 a 69 anos	308	336	644
70 a 79 anos	177	199	376
80 anos e mais	91	96	187
Total	3.140	3.328	6.468

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
PADRE MARCOS	90	78	73	67

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	21	24	17	12	10
II. Neoplasias (tumores)	26	17	23	37	16
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	5	4	1	3
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	3	4	1	2
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	2	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	-	3	2	4	4
VII. Doenças do olho e anexos	1	1	1	2	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	2
IX. Doenças do aparelho circulatório	21	25	24	12	13
X. Doenças do aparelho respiratório	21	29	29	27	24
XI. Doenças do aparelho digestivo	11	10	21	33	17

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	8	5	3	9	6
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	3	3	3	2	8
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	11	11	9	17	11
XV. Gravidez parto e puerpério	46	56	59	43	48
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	6	3	7	9	8
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	3	2	3	3
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	2	1	1	1
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	27	30	45	51	38
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	1	-	-	6	4
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	206	230	256	270	218

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	6	3	-	3
II. Neoplasias (tumores)	6	4	7	7
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	1	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	9	5	6
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	-	2	2	1
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	25	29	27	25
X. Doenças do aparelho respiratório	5	7	2	6
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	4	1	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	1	-	1
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	-	1	4
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	-	1	3
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	-	3
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	1	1	2
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	4	7	8	6
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	59	69	56	73

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 20/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A análise dos dados demográficos do município de Padre Marcos/PI evidencia um perfil populacional relativamente equilibrado entre os sexos, com leve predominância do sexo feminino no total da população. Observa-se que a maior concentração populacional se encontra nas faixas etárias economicamente ativas, especialmente entre adultos jovens e de meia-idade, o que representa um potencial importante para o desenvolvimento social e econômico do município, além de demandar políticas públicas voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e manutenção da capacidade funcional dessa população.

Também se observa a presença significativa de população idosa, o que demonstra um processo gradual de envelhecimento populacional, fenômeno já observado em diversas regiões do país. Esse cenário reforça a importância do fortalecimento das ações de atenção às condições crônicas, acompanhamento longitudinal na Atenção Primária à Saúde e ampliação de estratégias de promoção do envelhecimento saudável e ativo.

Em relação aos nascidos vivos, observa-se uma tendência de redução gradual ao longo dos últimos anos. Esse comportamento demográfico acompanha transformações sociais observadas em diversos municípios brasileiros, como mudanças no perfil reprodutivo, planejamento familiar e transformações socioeconômicas. Apesar da redução no número de nascimentos, o município mantém o compromisso com a qualificação da assistência materno-infantil, buscando garantir acompanhamento adequado no pré-natal, parto e puerpério, bem como ações voltadas ao desenvolvimento saudável da primeira infância.

No que se refere à morbidade hospitalar, as internações observadas refletem um perfil epidemiológico caracterizado pela presença tanto de condições agudas quanto de doenças crônicas, cenário compatível com o processo de transição epidemiológica vivenciado pelos municípios brasileiros. Destacam-se internações relacionadas às condições do aparelho respiratório, circulatório, digestivo, além de eventos associados à gravidez, parto e puerpério, o que evidencia a necessidade contínua de fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento clínico na rede de atenção à saúde.

As internações decorrentes de lesões e outras consequências de causas externas também aparecem entre os grupos relevantes, indicando a importância de estratégias intersetoriais voltadas à promoção da segurança, prevenção de acidentes e conscientização da população. Observa-se ainda a presença de internações relacionadas a doenças infecciosas e parasitárias, que, embora apresentem tendência de redução ao longo do período analisado, reforçam a necessidade da continuidade das ações de vigilância em saúde, imunização e controle de agravos.

Quanto ao perfil de mortalidade, observa-se predominância de óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, especialmente aquelas associadas ao aparelho circulatório, padrão amplamente observado em nível nacional. Esse cenário reforça a importância das ações de promoção da saúde, incentivo a hábitos de vida saudáveis, controle de fatores de risco e acompanhamento contínuo de pessoas com condições crônicas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Também são observados óbitos relacionados a neoplasias, doenças endócrinas e metabólicas, doenças respiratórias e causas externas, evidenciando a complexidade do perfil epidemiológico local. Esses achados indicam a necessidade permanente de qualificação das ações de prevenção, diagnóstico oportuno e acompanhamento adequado dos usuários nos diferentes níveis de atenção.

De modo geral, os dados demográficos e de morbimortalidade indicam que o município de Padre Marcos/PI apresenta desafios compatíveis com a realidade de municípios de pequeno porte, convivendo com demandas relacionadas tanto às doenças transmissíveis quanto às doenças crônicas e aos agravos decorrentes de causas externas. Nesse contexto, a gestão municipal de saúde tem desenvolvido esforços contínuos para fortalecer a rede de atenção, ampliar o acesso aos serviços e qualificar as ações de promoção, prevenção e cuidado, visando à melhoria constante dos indicadores de saúde e da qualidade de vida da população.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	79.335
Atendimento Individual	20.882
Procedimento	34.882
Atendimento Odontológico	1.666

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteSES e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	418	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-

05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteSES e materiais especiais	94	21.150,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	512	21.150,00	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
 Data da consulta: 20/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
 Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	418	-
Total	418	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
 Data da consulta: 20/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Os dados de produção do SUS são essenciais porque mostram tudo o que o sistema de saúde está realizando em termos de atendimentos, procedimentos, consultas, cirurgias, exames e outros serviços de saúde. Essas informações ajudam a entender se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente e se as ações estão alcançando a população atendida.

Ao analisar esses dados, gestores, profissionais de saúde e a sociedade podem acompanhar o volume de serviços prestados, identificar áreas que precisam de mais atenção e planejar melhorias na assistência. Além disso, esses dados são fundamentais para a prestação de contas, transparência e controle social, pois demonstram claramente o que foi feito com os recursos públicos destinados à saúde. Sintetizando, os dados de produção do SUS são uma ferramenta vital para garantir que o sistema seja eficiente, transparente e capaz de atender às necessidades da população de forma adequada.

Este capítulo deve ser analisado em conjunto com os indicadores estipulados no Plano Municipal de Saúde, bem como as ações da Programação Anual de Saúde e, assim como preconiza a Lei Complementar N° 141, de 13 de janeiro de 2012. Desta forma, este Relatório pretende contemplar a oferta, cobertura e produção de serviços estratégicos ao monitoramento das ações da Programação Anual de Saúde em Padre Marcos (PI).

Os dados referentes à Atenção Primária à Saúde foram extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), que é constituído por registros do Prontuário Eletrônico do Cidadão no e-SUS, Estratégia de Informatização da Atenção Básica.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	1	1
POSTO DE SAUDE	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	6	6
UNIDADE MISTA	1	0	0	1
Total	1	0	10	11

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 13/03/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	0	1	10
Total	9	0	1	10

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 13/03/2026.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

• Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

A rede física de estabelecimentos de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Padre Marcos é composta por **11 estabelecimentos de saúde**, conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) referentes a dezembro de 2025. Observa-se que **10 unidades são de gestão municipal**, enquanto **1 estabelecimento possui gestão dupla**, demonstrando que a oferta de serviços de saúde no território é predominantemente organizada e executada pela gestão municipal.

No que se refere ao tipo de estabelecimento, destaca-se a presença de **6 Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde**, que constituem a base da **Atenção Primária à Saúde (APS)** e desempenham papel fundamental na coordenação do cuidado e no acesso inicial da população aos serviços de saúde. Complementam essa rede um **posto de saúde**, um **consultório isolado**, uma **unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência**, uma **central de gestão em saúde** e uma **unidade mista**, esta última com gestão compartilhada.

Quanto à natureza jurídica, verifica-se que **todos os estabelecimentos estão vinculados à administração pública**, sendo **9 unidades pertencentes diretamente ao poder executivo municipal** e **1 unidade sob gestão dupla**, o que evidencia a forte responsabilidade do município na manutenção da infraestrutura e na organização da rede assistencial.

De modo geral, a estrutura existente demonstra que o município mantém uma **rede de serviços voltada principalmente para a Atenção Primária**, com apoio de unidade voltada ao atendimento de urgência e de uma unidade mista para suporte assistencial. Essa configuração é compatível com o porte populacional do município e reforça o papel da gestão municipal na garantia do acesso aos serviços básicos de saúde, além da necessidade de articulação com a rede regional para a oferta de serviços de média e alta complexidade.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	1	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	3	4	16	19
	Informais (09)	0	1	0	4	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	2	4	14	11	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 08/04/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2021	2022	2023	2024
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	1	1
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	49	48	47	47

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2021	2022	2023	2024
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	18	18	23	30

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 08/04/2026.

• Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A força de trabalho em saúde no município de Padre Marcos é composta majoritariamente por profissionais vinculados à administração pública municipal, conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) referentes a dezembro de 2025. Observa-se a presença de profissionais distribuídos entre diferentes categorias ocupacionais, incluindo médicos, enfermeiros, profissionais de nível superior de outras áreas, profissionais de nível médio e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), evidenciando uma estrutura multiprofissional voltada para o funcionamento da rede de serviços do SUS.

Entre os vínculos de trabalho, destaca-se a predominância de **servidores estatutários e empregados públicos**, totalizando 47 postos de trabalho nos dados mais recentes disponíveis, com forte participação de profissionais de nível médio e Agentes Comunitários de Saúde, que desempenham papel essencial na organização da Atenção Primária à Saúde. Também se observa a presença de **contratações temporárias e cargos em comissão**, que somam 31 postos de trabalho em 2025, principalmente entre profissionais de nível superior e de nível médio, demonstrando que parte significativa da força de trabalho ainda depende de vínculos temporários para garantir o funcionamento dos serviços.

Além disso, há registros pontuais de **profissionais autônomos, bolsistas e vínculos informais**, principalmente relacionados à atuação médica ou a funções específicas, o que indica estratégias complementares utilizadas pelo município para suprir necessidades assistenciais.

A análise da série histórica mostra relativa estabilidade no quantitativo de servidores efetivos entre 2021 e 2024, enquanto se observa **crescimento no número de contratos temporários**, passando de 18 em 2021 para 30 em 2024. Esse cenário sugere a ampliação da rede de serviços ou da necessidade de reforço da força de trabalho, porém também evidencia a importância de estratégias de planejamento e provimento de pessoal que priorizem vínculos mais estáveis.

De forma geral, o município mantém uma equipe multiprofissional capaz de sustentar as ações e serviços do SUS, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Contudo, os dados indicam a necessidade de **fortalecer políticas de gestão do trabalho e valorização profissional**, buscando ampliar a estabilidade dos vínculos e garantir maior continuidade e qualidade na prestação dos serviços à população.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços públicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, de modo a considerar os determinantes sociais, aprimorando a política de atenção básica e a consolidação das redes regionalizadas de atenção integral às pessoas no território.

OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar Ações de Promoção e Prevenção à Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar Campanhas Educativas Conforme Calendário Anual da Saúde	Número Absoluto de Campanhas Educativas realizadas.	Número	2021	1	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Fomentar as equipes sobre a importância do cumprimento das ações de saúde do calendário anual da Saúde									
2. Ampliar a oferta a população acesso ao Programa de Controle ao Tabagismo.	Número de grupos de Programas de tabagismo ofertados.	Número	2021	0	3	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - garantir acesso a todos os pacientes do município que desejam se abster do tabaco									
3. Aumentar a cobertura de Acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.	Cobertura de Acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.	Percentual	2021	80,28	95,00	92,00	Percentual	95,00	103,26
Ação Nº 1 - Realizar políticas Inter setoriais e Intensificar as visitas domiciliares dos ACS para o acompanhamento 1 vez por semestre									
4. Implantar e desenvolver o programa de alimentação saudável e nutricional PROTEJA	Número absoluto de programas de alimentação saudável mantidos.	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - disponibilizar os micronutrientes para as crianças utilizando as escolas como parceira									

OBJETIVO Nº 1.2 - Fortalecer a Atenção Primária, com Ênfase no ESF, propiciando ampliação do acesso, visando melhoria.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Promover a ampliação da Cobertura populacional estimada pelas Equipes Saúde da Família.	Percentual de ampliação cobertura - ESF	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Otimização dos cadastros das famílias para garantir o vínculo e assim uma cobertura assistencial efetiva									
2. Reformar Unidades Básicas de Saúde	Número Absoluto de reformas realizadas.	Número	2021	0	2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Planejar para os próximos anos as reformas									

OBJETIVO Nº 1.3 - Fortalecer a Linha de Cuidado em Saúde Bucal, ampliando oferta de atendimento.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Promover a ampliação da Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na atenção básica.	Percentual da cobertura Saúde Bucal	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar aos usuários de forma ampla e humanizada o acesso aos serviços de saúde bucal									

2. Manter Laboratório de Próteses Dentária implantado.	Número Absoluto de Laboratório de próteses dentárias implantados	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o funcionamento básico do laboratório de próteses dentária, ampliando o acesso a todos os usuários.									
3. Aumentar 15 % ao percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada.	Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada	Percentual	2021	7,00	15,00	10,00	Percentual	8,00	80,00
Ação Nº 1 - Desenvolver dentro das escolas ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal, utilizando a escovação supervisionada									
4. Realizar atendimento odontológico em todas às gestantes no curso do pré-natal na APS	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.	Percentual	2021	70,00	100,00	100,00	Percentual	95,00	95,00
Ação Nº 1 - Garantir com qualidade o acesso a todas as gestantes o atendimento odontológico em tempo oportuno									
OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e colo do útero.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar Exames Citopatológicos do colo do útero em Mulheres de 25 a 64 anos na população residente	Razão de exames Citopatológicos do colo do útero realizados.	Percentual	2021	0,01	0,60	0,58	Percentual	0,29	50,00
Ação Nº 1 - Realizar levantamento das mulheres na idade preconizada e efetuar campanha educativa e mutirões coletando amostras e conscientizando as mulheres.									
2. Realizar exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 60 anos na população residente.	Razão de exames de mamografia realizados	Percentual	2021	0,06	0,50	0,45	Percentual	0,06	13,33
Ação Nº 1 - Realizar campanha educativa,OUTUBRO ROSA, objetivando a conscientização da mulheres e disponibilizar os exames mamográficos para as mulheres da faixa etária									
OBJETIVO Nº 1.5 - Qualificar e Organizar a Linha de Cuidado a Saúde Materna e Infantil, garantindo acesso, acolhimento e resolutividade.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	Número Absoluto de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	Número	2021	0	0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Ampliar a vigilância das ESF durante a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil e materno									
2. Manter a redução da mortalidade Infantil.	Número de óbitos infantis ocorridos no período.	Número	2021	0	0	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Garantir qualidade do pré-natal e assegurar as referências regionais									
3. Ampliar proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.	Proporção de ampliação de parto normal no sistema SUS.	Percentual	2021	28,90	40,00	38,00	Percentual	19,20	50,53
Ação Nº 1 - Fortalecer a sensibilização das gestantes durante os pré-natais sobre a importância do parto normal									
4. Reduzir proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	Proporção reduzida de gravidez na adolescência	Proporção	2021	20,00	13,00	16,00	Proporção	12,28	76,75
Ação Nº 1 - perfeioar ações de prevenção de gravidez na adolescência e promoção da saúde nas escolas e comunidades									

5. Aumentar para 90% a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 consultas de pré-natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	Percentual	2021	80,00	90,00	88,00	Percentual	90,00	102,27
Ação Nº 1 - Implementar o controle de agendamento do pré-natal e busca das gestantes faltosas									
6. Aumentar para 90% acesso ao teste rápido de sífilis das gestantes usuárias do SUS.	Percentual de gestantes usuárias do SUS que realizaram teste rápido para a sífilis.	Percentual	2021	80,00	90,00	88,00	Percentual	90,00	102,27
Ação Nº 1 - Disponibilizar testes rápidos em 02 trimestres, fazendo o acompanhamento dos resultados em tempo oportuno									
7. Aumentar para 90% acesso ao teste rápido de HIV das gestantes usuárias do SUS.	Percentual de gestantes usuárias do SUS que realizaram teste rápido para a HIV.	Percentual	2021	80,00	90,00	88,00	Percentual	90,00	102,27
Ação Nº 1 - Disponibilizar testes rápidos em 02 trimestres, fazendo o acompanhamento dos resultados em tempo oportuno									
OBJETIVO Nº 1.6 - Ampliar o acesso à Linha de Cuidado em Saúde Mental, de forma articulada com demais pontos.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar a Linha de Cuidado nas unidades de Atenção Básica	Número Absoluto de linhas de cuidado na AB implantado	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Arquitetar com todas as equipes o desenvolvimento de linhas e protocolos de cuidados em todos os programas e grupos de risco e vulnerabilidades									
OBJETIVO Nº 1.7 - Fortalecer a Linha de Cuidado a pessoa com deficiência.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar a Estratificação de Risco da Linha de Cuidado.	Percentual de estratificação de risco e linha de cuidado implantado.	Percentual	2021	0,00	100,00	75,00	Percentual	75,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver a linhas de cuidados para os portadores de deficiência, utilizando o manual do MS.									
OBJETIVO Nº 1.8 - Fortalecer a Linha de Cuidado ao Idoso.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar à Estratificação de Risco.	Percentual de Estratificação de risco realizado.	Percentual	2021	70,00	100,00	100,00	Percentual	75,00	75,00
Ação Nº 1 - Desenvolver a linhas de cuidados para os idosos, utilizando o manual do MS.									
OBJETIVO Nº 1.9 - Qualificar o cuidado à Criança e ao Adolescente.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Retomar as ações do Programa Saúde na Escola.	Proporção de ações do Programa Saúde na Escola executadas.	Proporção	2021	0,00	85,00	85,00	Proporção	80,00	94,12
Ação Nº 1 - Executar o planejamento de todas as ações do PSE em todas as escolas utilizando todas as ESF									
2. Manter reduzido o número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	Número Absoluto de novos casos de sífilis.	Número	2021	0	0	0	Número	0	0

Ação Nº 1 - Qualificar as consultas de pré-natal, disponibilizar testes rápidos de sífilis em 02 trimestres e acompanhar os resultados em tempo oportuno, além de tratar ainda no pré-natal quando for acometida

3. Manter reduzido o número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	Número Absoluto de casos de Aids em menores de 5 anos.	Número	2021	0	0	0	Número	0	0
--	--	--------	------	---	---	---	--------	---	---

Ação Nº 1 - Qualificar as consultas de pré-natal, disponibilizar testes rápidos de HIV em 02 trimestres e acompanhar os resultados em tempo oportuno, além de ofertar o tratamento ainda no pré-natal quando for acometida

OBJETIVO Nº 1 .10 - Fortalecer a Assistência Farmacêutica, Garantindo Medicamento da Atenção Básica.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Estruturar as farmácias básicas das UBS.	Número de farmácias básicas estruturadas	Número	2021	2	2	2	Número	2,00	100,00

Ação Nº 1 - Planejar para os próximos anos a estruturação das farmácias básicas

2. Disponibilizar todos os medicamentos padronizados na RENAME.	Percentual de medicamentos padronizados RENAME disponibilizados.	Percentual	2021	70,00	100,00	100,00	Percentual	85,00	85,00
---	--	------------	------	-------	--------	--------	------------	-------	-------

Ação Nº 1 - Realizar o planejamento baseado na necessidade da população e assegurar a aquisição das medicações básicas

DIRETRIZ Nº 2 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio da qualificação das ações de vigilância em saúde.

OBJETIVO Nº 2 .1 - Fortalecer ações da Vigilância Epidemiológica.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Alcançar coberturas vacinais (CV) de 95% do calendário Básico de Vacinação da Criança.	Percentual de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas.	Percentual	2021	90,00	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa dos faltosos e atualizar o calendário vacinal

2. Encerrar os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	Percentual de casos de DNCI encerrados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
--	--	------------	------	--------	--------	--------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Supervisionar semanalmente todas as notificações para otimizar adequadamente o registro no SINAN

3. Proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	Proporção de cura nos casos novos de Hanseníase.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
---	--	------------	------	--------	--------	--------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Qualificar os profissionais da atenção básica na identificação da enfermidade e realizar atividades educativas com o objetivo de incentivar o início precoce do tratamento e aumentar a captação dos casos novos, para promover a cura de 100% dos casos de hanseníase.r

4. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	Proporção	2021	90,00	95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
--	--	-----------	------	-------	-------	-------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Promover a captação dos comunicantes para a realização do processo de controle e prevenção da doença e realizar a visita domiciliar aos faltosos

5. Investigar os óbitos maternos.	Percentual de investigação de óbitos maternos	Percentual	2021	95,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
-----------------------------------	---	------------	------	-------	--------	--------	------------	--------	--------

Ação Nº 1 - Ampliar a vigilância das ESF durante a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil e materno

6. Investigar óbitos infantis e fetais.	Percentual de investigação de óbitos infantis e fetais.	Percentual	2021	95,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitorar semanalmente através das equipes os casos de óbitos infantis e fetais, para investigar em tempo hábil.									
7. Reduzir o número de Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por ano pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças de aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	Número Absoluto de redução de Mortalidade prematura.	Número	2021	9	5	6	Número	7,00	116,67
Ação Nº 1 - Assegurar a qualificação das ações da APS para o atendimento integral a população idosa com o objetivo de promover a redução de mortalidade prematura									
OBJETIVO Nº 2.2 - Desenvolver ações de prevenção e combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o Plano de Contingência atualizado e funcional para enfrentamento da Covid-19.	Nº de atualizações do Plano para enfrentamento da Covid-19 realizados.	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar mensalmente uma reunião técnica com as equipes de saúde e vigilâncias com o objetivo de analisar e atualizar o plano de contingência da covid									
2. Realizar ações preventivas não farmacológicas de combate ao coronavírus.	Número de Medidas não-farmacológicas de combate ao coronavírus	Número	2021	12	10.000	20	Número	1,00	5,00
Ação Nº 1 - - Divulgação e execução de higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras em serviços de saúde, uso de máscaras na população em geral									
3. Capacitar os trabalhadores do SUS para as estratégias de ação durante a pandemia e pós-pandemia.	Número de capacitações realizadas	Número	2021	2	8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Executar conforme planejado capacitação para os profissionais de saúde para abordagem durante e pós pandemia									
OBJETIVO Nº 2.3 - Fortalecer ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Trabalhador.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Percentual de análises realizadas em amostras de água para consumo humano	Percentual	2021	70,00	80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e controle da qualidade da água									
2. Número de ciclos que atinjam o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	Número Absoluto de visitas realizadas por agente de endemias.	Número	2021	5	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Disseminar todas as informações a cerca das três patologias transmitidas pelo aedes aegypti e Intensificar as ações de promoção e prevenção de combate									
3. Realizar o preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Percentual de preenchimento das notificações de agravos relacionados ao trabalho	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Implementar prática de notificações de agravos relacionadas ao trabalho dentro da APS

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento da Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde.

OBJETIVO Nº 3.1 - Fortalecer a Educação Permanente, adotando gestão participativa, monitorando e avaliando o efetivo cumprimento dos objetivos e metas.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Disponibilizar Curso/Capacitações, de aperfeiçoamento em diversas áreas da Secretaria de Saúde.	Número Absoluto de cursos disponibilizados	Número	2021	2	8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Incluir no calendário todas as capacitações planejadas para o ano e executá-las									
2. Criar Protocolos de Atendimento nos diversos setores da saúde.	Número Absoluto de protocolos de atendimento criados.	Número	2021	0	6	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Desenvolver com a equipe de saúde e equipe técnica protocolos de todas linhas de cuidado na APS									

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecimento do Controle Social do SUS.

OBJETIVO Nº 4.1 - Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros de Saúde estabelecendo um canal de comunicação da SMS e CMS com a população, garantindo transparência e participação social.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar Conferência Municipal de Saúde no quadriênio.	Número Absoluto de conferências realizado.	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Planejar para o ano de 2025 a realização da conferencia de saúde									
2. Realizar Treinamentos para os Conselheiros de Saúde.	Número Absoluto de treinamentos realizados para conselheiros.	Número	2021	0	4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Executar de forma planejada capacitações para todos os conselheiros de saúde									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Realizar Campanhas Educativas Conforme Calendário Anual da Saúde	6	6
	Realizar Conferência Municipal de Saúde no quadriênio.	1	1
	Disponibilizar Curso/Capacitações, de aperfeiçoamento em diversas áreas da Secretaria de Saúde.	2	2
	Estruturar as farmácias básicas das UBS.	2	2
	Reformar Unidades Básicas de Saúde	1	1
	Manter Laboratório de Próteses Dentaria implantado.	1	1
	Disponibilizar todos os medicamentos padronizados na RENAME.	100,00	85,00
	Criar Protocolos de Atendimento nos diversos setores da saúde.	2	1
	Realizar Treinamentos para os Conselheiros de Saúde.	1	1
301 - Atenção Básica	Realizar Campanhas Educativas Conforme Calendário Anual da Saúde	6	6
	Realizar Conferência Municipal de Saúde no quadriênio.	1	1
	Disponibilizar Curso/Capacitações, de aperfeiçoamento em diversas áreas da Secretaria de Saúde.	2	2

Manter o Plano de Contingência atualizado e funcional para enfrentamento da Covid-19.	1	1
Alcançar coberturas vacinais (CV) de 95% do calendário Básico de Vacinação da Criança.	95,00	95,00
Estruturar as farmácias básicas das UBS.	2	2
Retomar as ações do Programa Saúde na Escola.	85,00	80,00
Ampliar à Estratificação de Risco.	100,00	75,00
Implantar a Estratificação de Risco da Linha de Cuidado.	75,00	75,00
Implantar a Linha de Cuidado nas unidades de Atenção Básica	1	1
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	0	0
Realizar Exames Citopatológicos do colo do útero em Mulheres de 25 a 64 anos na população residente	0,58	0,29
Promover a ampliação da Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na atenção básica.	100,00	100,00
Promover a ampliação da Cobertura populacional estimada pelas Equipes Saúde da Família.	100,00	100,00
Ampliar a oferta a população acesso ao Programa de Controle ao Tabagismo.	3	3
Criar Protocolos de Atendimento nos diversos setores da saúde.	2	1
Realizar ações preventivas não farmacológicas de combate ao coronavírus.	20	1
Encerrar os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	100,00	100,00
Disponibilizar todos os medicamentos padronizados na RENAME.	100,00	85,00
Manter reduzido o número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	0
Manter a redução da mortalidade Infantil.	0	1
Realizar exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 60 anos na população residente.	0,45	0,06
Aumentar a cobertura de Acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.	92,00	95,00
Realizar o preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100,00	100,00
Capacitar os trabalhadores do SUS para as estratégias de ação durante a pandemia e pós-pandemia.	2	1
Proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	100,00	100,00
Manter reduzido o número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	0
Ampliar proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.	38,00	19,20
Aumentar 15 % ao percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada.	10,00	8,00
Implantar e desenvolver o programa de alimentação saudável e nutricional PROTEJA	1	1
Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	95,00	100,00
Realizar atendimento odontológico em todas às gestantes no curso do pré-natal na APS	100,00	95,00
Reduzir proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	16,00	12,28
Aumentar para 90% a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 consultas de pré-natal.	88,00	90,00
Investigar os óbitos maternos.	100,00	100,00
Aumentar para 90% acesso ao teste rápido de sífilis das gestantes usuárias do SUS.	88,00	90,00
Investigar óbitos infantis e fetais.	100,00	100,00
Aumentar para 90% acesso ao teste rápido de HIV das gestantes usuárias do SUS.	88,00	90,00
Reduzir o número de Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por ano pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças de aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	6	7

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	0	0
	Manter a redução da mortalidade Infantil.	0	1
	Ampliar proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.	38,00	19,20
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Promover a ampliação da Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na atenção básica.	100,00	100,00
	Ampliar a oferta a população acesso ao Programa de Controle ao Tabagismo.	3	3
	Manter Laboratório de Próteses Dentária implantado.	1	1
	Aumentar 15 % ao percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada.	10,00	8,00
304 - Vigilância Sanitária	Manter o Plano de Contingência atualizado e funcional para enfrentamento da Covid-19.	1	1
	Realizar ações preventivas não farmacológicas de combate ao coronavírus.	20	1
	Capacitar os trabalhadores do SUS para as estratégias de ação durante a pandemia e pós-pandemia.	2	1
305 - Vigilância Epidemiológica	Alcançar coberturas vacinais (CV) de 95% do calendário Básico de Vacinação da Criança.	95,00	95,00
	Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80,00	100,00
	Manter o Plano de Contingência atualizado e funcional para enfrentamento da Covid-19.	1	1
	Encerrar os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	100,00	100,00
	Número de ciclos que atinjam o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	6	6
	Realizar ações preventivas não farmacológicas de combate ao coronavírus.	20	1
	Proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	100,00	100,00
	Realizar o preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100,00	100,00
	Capacitar os trabalhadores do SUS para as estratégias de ação durante a pandemia e pós-pandemia.	2	1
	Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	95,00	100,00
	Investigar os óbitos maternos.	100,00	100,00
	Investigar óbitos infantis e fetais.	100,00	100,00
	Reduzir o número de Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por ano pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças de aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	6	7
306 - Alimentação e Nutrição	Implantar e desenvolver o programa de alimentação saudável e nutricional PROTEJA	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R\$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R\$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R\$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R\$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R\$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R\$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R\$)	Outros recursos destinados à Saúde (R\$)	Total(R\$)
0 - Informações Complementares	Corrente	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	20.000,00	1.100,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	21.100,00
	Capital	N/A	70.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	70.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	3.491.500,00	6.051.515,00	623.800,00	5.000,00	N/A	N/A	N/A	10.171.815,00
	Capital	N/A	611.500,00	401.500,00	2.000,00	454.183,13	N/A	N/A	N/A	1.469.183,13
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	231.000,00	0,00	594.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	825.500,00
	Capital	N/A	20.000,00	0,00	35.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	55.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	22.000,00	11.000,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	33.000,00
	Capital	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	21.000,00	230.935,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	251.935,00
	Capital	0,00	N/A	3.000,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	0,00	N/A	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
 Data da consulta: 08/04/2026.

• Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde (PAS) é um instrumento fundamental de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que detalha as metas, ações e indicadores que deverão ser executados ao longo do ano, com base nas diretrizes estabelecidas no Plano de Saúde. Sua principal finalidade é garantir a operacionalização das políticas públicas de saúde de forma organizada, eficiente e orientada por prioridades locais e regionais.

A PAS permite aos gestores organizarem os recursos disponíveis, definirem responsabilidades, prazos e estratégias para o alcance dos objetivos propostos, além de possibilitar o acompanhamento sistemático do desempenho das ações. É uma ferramenta essencial para a **gestão baseada em resultados**, pois viabiliza a comparação entre o que foi planejado e o que foi efetivamente executado, facilitando a identificação de falhas, a tomada de decisões e o redirecionamento de estratégias. Notamos que a maioria das metas e ações pactuadas foram desenvolvidas, algumas em andamento e outras sendo reajustadas para cumprimento durante os próximos quadrimestres.

A seguir apresentam-se as informações de acompanhamento e monitoramento das Diretrizes, Objetivos, Metas, Indicadores e Ações referentes ao 3º quadrimestre da PAS 2025. Ressalta-se que os indicadores os quais obtiveram resultados que superaram a meta ano, neste quadrimestre, serão revistos, quando da revisão do plano 2022 - 2025.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.

Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 08/04/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção											
Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	4.144.194,29	6.512.206,08	184.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.823,41
	Capital	0,00	194.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.924,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	545.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.075,22
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	174.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.562,20
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.884.193,81	6.686.768,28	184.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755.385,13
(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde											

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,86 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	88,95 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	12,70 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	94,97 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	16,31 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	35,13 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.817,47
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	49,76 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	7,98 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	22,89 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,66 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	59,17 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	22,60 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2026.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.231.666,00	3.231.666,00	2.373.639,82	73,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.910,00	69.910,00	17.428,82	24,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	4.421,71	27,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.489.186,00	1.489.186,00	874.958,01	58,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.656.570,00	1.656.570,00	1.476.831,28	89,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.486.850,00	23.486.850,00	19.233.188,21	81,89
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.030.712,91	83,50
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	2.911,72	5,82
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	534.606,83	56,27
Cota-Parte do ICMS	4.482.850,00	4.482.850,00	3.664.471,70	81,74
Cota-Parte do IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	485,05	12,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.718.516,00	26.718.516,00	21.606.828,03	80,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.100.000,00	5.078.137,04	4.339.118,59	85,45	4.339.018,59	85,45	4.228.083,29	83,26	100,00
Despesas Correntes	3.488.500,00	4.549.637,04	4.144.194,29	91,09	4.144.094,29	91,09	4.033.158,99	88,65	100,00
Despesas de Capital	611.500,00	528.500,00	194.924,30	36,88	194.924,30	36,88	194.924,30	36,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	251.000,00	626.893,49	545.075,22	86,95	545.075,22	86,95	542.819,62	86,59	0,00
Despesas Correntes	231.000,00	606.893,49	545.075,22	89,81	545.075,22	89,81	542.819,62	89,44	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.484.000,00	5.783.030,53	4.884.193,81	84,46	4.884.093,81	84,46	4.770.902,91	82,50	100,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.884.193,81	4.884.093,81	4.770.902,91
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.884.193,81	4.884.093,81	4.770.902,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.241.024,20		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.643.169,61	1.643.069,61	1.529.878,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,60	22,60	22,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
-----------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------------	--	---

Empenhos de 2025	3.241.024,20	4.884.193,81	1.643.169,61	113.290,90	0,00	0,00	0,00	113.290,90	0,00	1.643.169,61
Empenhos de 2024	2.962.050,39	4.266.053,47	1.304.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.003,08
Empenhos de 2023	2.490.909,77	3.453.286,79	962.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.377,02
Empenhos de 2022	2.171.215,07	2.848.492,68	677.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.277,61
Empenhos de 2021	1.729.003,20	2.188.393,58	459.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.390,38
Empenhos de 2020	1.258.304,25	1.697.117,32	438.813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.813,07
Empenhos de 2019	1.307.632,63	1.595.928,29	288.295,66	0,00	35.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	324.236,60
Empenhos de 2018	1.271.001,69	1.690.742,70	419.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.741,01
Empenhos de 2017	1.097.184,27	1.348.265,62	251.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.081,35
Empenhos de 2016	1.241.743,66	1.667.912,08	426.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.168,42
Empenhos de 2015	1.105.942,12	1.525.454,28	419.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.512,16
Empenhos de 2014	1.035.829,34	1.370.484,63	334.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.655,29
Empenhos de 2013	867.468,03	1.315.002,22	447.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.534,19

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
---	------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
--	------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	8.426.433,13	8.426.433,13	6.956.203,20	82,55
Provenientes da União	6.818.950,00	6.818.950,00	6.606.639,36	96,89

Provenientes dos Estados	1.607.483,13	1.607.483,13	349.563,84	21,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	8.426.433,13	8.426.433,13	6.956.203,20	82,55

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	7.540.998,13	7.067.429,59	6.696.629,12	94,75	6.696.629,12	94,75	6.696.629,12	94,75	0,00
Despesas Correntes	6.683.315,00	6.785.720,89	6.696.629,12	98,69	6.696.629,12	98,69	6.696.629,12	98,69	0,00
Despesas de Capital	857.683,13	281.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	629.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	594.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	233.935,00	189.891,50	174.562,20	91,93	174.562,20	91,93	174.562,20	91,93	0,00
Despesas Correntes	230.935,00	186.891,50	174.562,20	93,40	174.562,20	93,40	174.562,20	93,40	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	8.429.433,13	7.366.821,09	6.871.191,32	93,27	6.871.191,32	93,27	6.871.191,32	93,27	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	11.640.998,13	12.145.566,63	11.035.747,71	90,86	11.035.647,71	90,86	10.924.712,41	89,95	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	880.500,00	718.393,49	545.075,22	75,87	545.075,22	75,87	542.819,62	75,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	254.935,00	225.891,50	174.562,20	77,28	174.562,20	77,28	174.562,20	77,28	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	104.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	12.913.433,13	13.149.851,62	11.755.385,13	89,40	11.755.285,13	89,39	11.642.094,23	88,53	100,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	8.426.433,13	7.363.821,09	6.871.191,32	93,31	6.871.191,32	93,31	6.871.191,32	93,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	4.487.000,00	5.786.030,53	4.884.193,81	84,41	4.884.093,81	84,41	4.770.902,91	82,46	100,00

FONTE: SIOPS, Piauf27/02/26 10:43:30

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos da	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 472.685,24	472685,24
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 749.892,00	749892,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 2.695.143,80	2695143,8
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R\$ 777,40	777,40
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 2.334.400,00	2334400,0

Serviços Públicos de Saúde	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 56.162,40	56162,40
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 18.000,00	18000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 11.000,00	11000,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 118.404,00	118404,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 40.378,53	40378,53
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 39.171,86	39171,86

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Ano Proposta	Identificadores				Valores			Monitoramento			
	Número da Proposta	Tipo Proposta	GND	Objeto	Valor Proposta	Valor Empenhado	Valor Desembolsado	Situação	Data de Finalização	Data Provável Finalização	Percentual Execução
2025	36000702464202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	504.224,00	504.224,00	504.224,00	Executado Totalmente			100 %
2025	36000702466202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Executado Totalmente			100 %
2025	36000705112202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Executado Parcialmente		Abr/26	96 %
2025	36000665322202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Executado Totalmente			100 %
2025	36000717468202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.176,00	180.176,00	180.176,00	Executado Parcialmente		Abr/26	96 %
2025	36000665328202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Executado Totalmente			100 %

Fonte: InvestSUS - FNS

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

A análise da execução orçamentária e financeira da saúde no município de Padre Marcos demonstra o compromisso da gestão municipal com o financiamento das ações e serviços públicos de saúde ao longo do exercício de 2025. A despesa total executada em saúde atingiu aproximadamente R\$ 11,75 milhões, com predominância de recursos aplicados na Atenção Básica, que concentrou cerca de R\$ 11,03 milhões, evidenciando a prioridade dada à Atenção Primária à Saúde como eixo estruturante da organização do sistema local de saúde.

Observa-se que grande parte do financiamento da saúde municipal é composta por transferências intergovernamentais, especialmente provenientes da União, que representam parcela significativa dos recursos destinados ao setor. Ainda assim, o município demonstrou esforço importante na aplicação de recursos próprios, destinando 22,60% da receita de impostos e transferências constitucionais para ações e serviços públicos de saúde, percentual superior ao mínimo constitucional de 15%, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012. Esse resultado reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do SUS no território.

No que se refere à composição das despesas, destaca-se a participação das despesas com pessoal (49,76%), refletindo o investimento na manutenção das equipes responsáveis pela oferta dos serviços de saúde. Também se observam despesas com serviços de terceiros (22,89%) e medicamentos (7,98%), elementos essenciais para o funcionamento da rede assistencial. Os investimentos em capital representaram 1,66% das despesas totais, indicando que, embora as despesas correntes ainda predominem, a gestão tem buscado gradualmente realizar investimentos para qualificação da infraestrutura e dos serviços.

Quanto à execução orçamentária por subfunção, a Atenção Básica apresentou elevado nível de execução, com percentual superior a 85%, demonstrando boa capacidade de utilização dos recursos programados. A Assistência Hospitalar e Ambulatorial também apresentou execução satisfatória, próxima de 87%, contribuindo para garantir o acesso da população a serviços complementares à atenção primária.

Em algumas subfunções, como Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, os registros de execução direta aparecem reduzidos ou não evidenciados no demonstrativo específico de despesas próprias. Entretanto, muitas dessas ações são financiadas por recursos transferidos fundo a fundo, que apresentaram execução expressiva ao longo do exercício, especialmente nas ações de Atenção Primária, Vigilância em Saúde, assistência farmacêutica e no pagamento do piso da enfermagem, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

De modo geral, os dados demonstram que o município mantém equilíbrio na gestão financeira da saúde, cumprindo os limites constitucionais de aplicação de recursos e priorizando as áreas estratégicas do SUS. Ao mesmo tempo, os resultados apontam oportunidades para ampliação progressiva de investimentos estruturantes e fortalecimento de algumas áreas programáticas, processo que vem sendo continuamente trabalhado pela gestão municipal com o objetivo de qualificar ainda mais a oferta de serviços à população.

Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

A análise da execução dos recursos provenientes de emendas parlamentares no exercício de 2025, no município de Padre Marcos, evidencia uma gestão eficiente e responsável na aplicação dos valores destinados ao fortalecimento das ações e serviços de saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Os recursos analisados, classificados majoritariamente como **incremento ao Piso da Atenção Primária (PAP)**, foram integralmente empenhados e desembolsados, com elevado percentual de execução, sendo a maior parte das propostas **executada totalmente (100%)** e as demais em fase final de execução, com percentual de aproximadamente **96%** e previsão de conclusão no início de 2026. Esse cenário demonstra adequada capacidade de planejamento, execução e acompanhamento dos recursos recebidos.

Destaca-se que todas as propostas seguiram rigorosamente os **planos de trabalho previamente estabelecidos**, assegurando que os recursos fossem aplicados conforme as finalidades pactuadas, contribuindo diretamente para a manutenção e qualificação dos serviços ofertados à população. A aplicação dos recursos esteve alinhada às necessidades do sistema local de saúde, reforçando o custeio das ações estratégicas da Atenção Primária.

Ressalta-se ainda que a execução financeira ocorreu de forma regular, com correspondência entre os valores propostos, empenhados e desembolsados, o que demonstra consistência nos processos de gestão orçamentária e financeira. As situações classificadas como “executado parcialmente” refletem apenas o ciclo natural de execução administrativa, já em fase avançada, sem prejuízo à efetividade das ações.

Por fim, cabe destacar que **o detalhamento completo da prestação de contas desses recursos encontra-se devidamente registrado nos balancetes contábeis do município e nos sistemas oficiais dos órgãos competentes**, garantindo transparência, rastreabilidade e conformidade com as normas vigentes.

De modo geral, os resultados evidenciam que os recursos oriundos de emendas parlamentares desempenharam papel relevante no financiamento da saúde municipal, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária e para a melhoria contínua da assistência prestada à população.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 08/04/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 08/04/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

As auditorias atuam como ação de controle que objetiva o exame, programado ou extraordinário de áreas de gestão consideradas relevantes, com vistas à análise e avaliação de processos, programas, ações, atividades e projetos ou destinada à apuração de denúncias.

As ações de controle são conduzidas pelas unidades técnicas que compõem os órgãos de controle, com vistas à verificação dos resultados no setor considerado o escopo de cada trabalho. O resultado das ações de controle deve contribuir para a melhoria da gestão governamental, de forma a possibilitar o aprimoramento dos controles internos administrativos e a geração de informações preventivas e oportunas para subsidiar o processo decisório do gestor da Secretaria.

11. Análises e Considerações Gerais

A análise das informações apresentadas neste Relatório Anual de Gestão evidencia que a Secretaria Municipal de Saúde de Padre Marcos manteve, ao longo do exercício de 2025, esforços contínuos para garantir o acesso da população às ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada do sistema.

Os dados demográficos e epidemiológicos demonstram que o município apresenta um perfil de saúde compatível com a realidade de municípios de pequeno porte, caracterizado pela coexistência de doenças crônicas não transmissíveis, agravos infecciosos e demandas relacionadas a causas externas. Esse cenário reforça a importância de estratégias permanentes voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento contínuo da população.

No que se refere à rede de serviços, observa-se que o município dispõe de uma estrutura assistencial predominantemente voltada à Atenção Primária, composta por unidades básicas de saúde distribuídas no território, além de outros estabelecimentos que contribuem para a organização da rede local. Essa estrutura tem possibilitado ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, ao mesmo tempo em que exige constante articulação com a rede regional para a garantia de atendimentos de média e alta complexidade.

Em relação à força de trabalho, destaca-se a presença de equipe multiprofissional responsável pela execução das ações e serviços de saúde. Embora exista predominância de vínculos efetivos, observa-se também a utilização de contratos temporários como estratégia de complementação da força de trabalho, realidade comum em diversos municípios brasileiros e que vem sendo gradualmente analisada pela gestão com vistas ao aprimoramento da política de gestão do trabalho.

No âmbito da execução orçamentária e financeira, verifica-se que o município cumpriu o percentual mínimo constitucional de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, alcançando **22,60% da receita de impostos e transferências constitucionais**, valor superior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente. Esse resultado demonstra o compromisso da gestão municipal com o financiamento da política pública de saúde.

A maior parte dos recursos foi direcionada para a Atenção Básica, refletindo a prioridade dada à organização do cuidado a partir da atenção primária. Ao mesmo tempo, observa-se que parte do financiamento da saúde municipal depende significativamente de transferências intergovernamentais, sobretudo da União, o que evidencia a importância da manutenção e fortalecimento do pacto federativo no financiamento do SUS.

De modo geral, os resultados apresentados neste relatório demonstram avanços na execução das ações planejadas na Programação Anual de Saúde, ainda que algumas metas e indicadores demandem acompanhamento contínuo e aperfeiçoamento das estratégias de gestão. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde tem buscado fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação, visando aprimorar cada vez mais a qualidade da assistência prestada à população.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Considerando os resultados alcançados no exercício de 2025 e os desafios identificados ao longo do processo de gestão, recomenda-se para o próximo exercício o desenvolvimento das seguintes ações estratégicas:

- **Fortalecer as ações da Atenção Primária à Saúde**, ampliando as estratégias de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições crônicas, com foco na melhoria dos indicadores de saúde da população.
- **Aprimorar os processos de planejamento, monitoramento e avaliação das ações da Programação Anual de Saúde**, buscando maior alinhamento entre metas pactuadas, execução das ações e resultados alcançados.
- **Investir gradualmente na qualificação da infraestrutura e dos equipamentos da rede de serviços de saúde**, visando ampliar a resolutividade da assistência prestada no município.
- **Fortalecer as políticas de gestão do trabalho e educação permanente em saúde**, incentivando a qualificação dos profissionais e a valorização da força de trabalho do SUS.
- **Ampliar as estratégias de vigilância em saúde**, com foco na prevenção e controle de agravos prioritários, incluindo doenças transmissíveis, condições crônicas e acidentes.
- **Aprimorar a gestão dos recursos financeiros**, buscando otimizar a utilização dos recursos disponíveis e ampliar oportunidades de captação de novos investimentos para o setor saúde.
- **Fortalecer a integração com a rede regional de saúde**, garantindo acesso oportuno da população aos serviços de média e alta complexidade.
- **Estimular a participação e o fortalecimento do controle social**, assegurando o acompanhamento das ações e políticas públicas de saúde pelo Conselho Municipal de Saúde.

MARIA LUCIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde
PADRE MARCOS/PI, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Introdução

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Auditorias

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
avaliado e aprovado.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
avaliado e aprovado.

Status do Parecer: Aprovado

PADRE MARCOS/PI, 08 de Abril de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Padre Marcos